核心 01 / EMT-1

總流程 | 先救命，再接續

起手

安全、防護、人數檢傷、119、器材就位。

初評

意識 → A 呼吸道 → B 呼吸 → C 循環。創傷用 XABCDE，X 大出血、D 神經、E 暴露。

順序

發現威脅立即處理；危急後送準備並行；二評、病史、重評、交接。

直接跳

無正常呼吸 + 無確定脈搏 → OHCA；有脈搏、通氣不足 → BVM；致命出血 → 先止血。

核心 02 / EMT-1

主副手 | 有接，才放

主手

判斷、意識與 ABC / XABCDE、危急辨識、指令、按壓 / 主要評估。

副手

器材、氧氣 / BVM、AED、量測、病史、通報、後送準備。

交接

「我要接手」→「我已接穩」→「好，我放手」。持續固定 / 加壓 / 密合占手，不能同時拿器材。

重評

變化隨時回 ABC。教材危急每 5 分鐘、非危急每 15 分鐘；救命處置不中斷。

核心 03 / EMT-1

OHCA | 分支要分清

辨識

呼吸與脈搏同時查，□10 秒。無正常呼吸 + 無確定脈搏 → 立即 CPR + AED。

按壓 / 通氣

100–120 / 分、約 5–6 cm、完全回彈。30:2，每口約 1 秒、看胸起。

AED

開、貼 / 插、清場、分析、依指示電擊、立即 CPR。首次不電擊也立即 CPR。

有脈搏後

再查呼吸：不足 → 每 6 秒一口 BVM；正常 → 監測後送。不電擊 ≠ 恢復心跳。

核心 04 / EMT-1

數字 | 口訣 | 器材

常用值

成人 RR 12–20、HR 60–100；GCS E4 V5 M6。教材 SpO□ 約 94–100%。

氧氣

NC 1–6、簡單面罩 6–10、NRM 10–15、BVM 10–15 L/min。通氣不足不能只戴面罩。

問與報

病史：主之前吃過藥敏感。胸痛：OPQRST。通報：病人要史已前到。

器材關鍵

OPA 依無反應 / 無嘔吐反射適應症；NPA 先查禁忌。成人口咽抽吸每次□15 秒。

情境 01 / EMT-1

過敏 / 嚴重過敏

主手

辨識呼吸道與循環危急，優先 ABC 支持、請求支援和後送。

副手

給氧、量測、詢問過敏與用藥史，協助轉運。

必抓

皮疹合併呼吸道或循環異常，就要當危急。 避免讓低血壓患者突然站起。 EMT-1 不自行施打腎上腺素，請求進階救護。

易漏

只看皮疹而漏掉休克。 讓藥物詢問延誤支援與後送。

情境 02 / EMT-1

氣喘 / 呼吸困難

主手

評估呼吸作功、說話、肺音、意識，辨識通氣不足。

副手

準備適當氧氣裝置、BVM、量測與後送。

必抓

舒服坐姿、適當給氧、盡速支援。 有脈搏但呼吸不足：BVM 每 6 秒一口，不做胸外按壓。 喘鳴消失不一定代表改善。

易漏

只有給氧，沒有重評通氣。 已無力呼吸時仍只戴面罩。

情境 03 / EMT-1

中風

主手

G-FAST、辨識危急、查最後正常時間，送適當醫院。

副手

測血糖、量測生命徵象、向家屬確認時間及病史。

必抓

G 眼球、F 臉、A 手、S 語言、T 最後正常時間。 測血糖，排除可模仿中風的低血糖。 超過某個時間窗仍須緊急評估後送。

易漏

只問何時發現，沒問最後正常。 讓患者自行進食喝水。

情境 04 / EMT-1

胸痛

主手

OPQRST、危急辨識、安排心電圖與適當醫院。

副手

量測、備 AED、12 導程貼片、通報與後送。

必抓

記錄症狀與時間，持續重評，AED 隨時可用。 按缺氧與呼吸狀況給氧，不因胸痛就一律最高濃度。 EMT-1 不直接給 NTG；詢問原處方與用藥史並回報。

易漏

等胸痛自己消失。 低血壓仍鼓勵使用降壓藥。

情境 05 / EMT-1

低血糖

主手

維持 ABC、評意識與吞嚥，處置後重評。

副手

測血糖、準備口服葡萄糖、詢問用藥與進食。

必抓

先測血糖，再確認清醒且能安全吞嚥。 口服葡萄糖後持續重評；指南常於 15 分鐘重測。 無反應 / 不能吞嚥時，停止口服，顧 ABC、支援與後送。

易漏

意識不清時把糖塗入口中或舌下。 只看血糖回升，沒有重評神經症狀。

情境 06 / EMT-1

安全帽脫除

主手

統一口令、評估、與副手明確交接頸椎支撐。

副手

持續減移、準備器材、確認接手再放開。

必抓

固定自己、固定支點、固定患者。 解扣、改用下顎 / 枕部支撐、脫帽、再接回固定。 頸圈不等於取代持續適當減移；固定後重評。

易漏

同一人固定頭部又離手拿器材。 沒有收到「已接穩」就放手。

情境 07 / EMT-1

大出血

主手

在 X 立即控制致命出血，辨識休克與後送。

副手

準備止血帶、記時間、量測，保暖與搬運。

必抓

先止血，再繼續其餘評估；兩人可並行。 直接加壓仍控制不了的肢體大出血，要早用止血帶。 放在傷口近心端，避開關節，收緊至止血並記時間。

易漏

完成全套二度評估才止血。 任意定時鬆開止血帶。

情境 08 / EMT-1

斷肢

主手

先救患者、控制出血與休克，安排後送。

副手

患者處置有人接續後，包裝斷肢、標示及隨人送醫。

必抓

先顧患者，斷肢由副手處理。 濕潤乾淨敷料包裹、密封袋、隔袋冷卻。 記錄事件 / 止血帶時間，斷肢隨患者送醫。

易漏

斷肢直接接觸冰、浸水或冷凍。 忙著找斷肢卻放著患者流血。

情境 09 / EMT-1

骨折

主手

檢查其他傷害，固定前後評估遠端神經血管。

副手

支撐患肢、備護墊與夾板、配合固定及搬運。

必抓

P 脈搏、S 感覺、M 運動，固定前後都做。 以原姿勢支撐固定，跨骨折上下關節。 固定後疼痛、脈搏、皮色與感覺變差要重評。

易漏

例行把變形部位拉直。 只包紮卻沒評遠端循環。

情境 10 / EMT-1

燒傷

主手

確認安全、停止灼傷、查吸入傷與燒傷範圍。

副手

局部適當冷卻、乾淨覆蓋、保暖與後送。

必抓

局部熱燙傷用流動涼水冷卻，目標約 20 分鐘；後送可同步。 不撕黏住的衣物，不用冰塊、不挑破水泡。 大面積 / 吸入傷等危急者，避免低體溫，優先 ABC 與後送。

易漏

所有燒傷一律長時間全身沖冷水。 塗藥膏、牙膏或直接冰敷。

情境 11 / EMT-1

氣胸 / 穿刺傷

主手

查胸傷、肺音與循環，辨識危急、快速後送。

副手

給氧、敷料 / 異物固定、反覆重評，準備 BVM。

必抓

專用可排氣胸封，或非密閉乾淨敷料，處理後反覆觀察。 貼敷料後呼吸惡化，要評估移除 / 鬆開並重評。 有異物不拔出；EMT-1 不做針刺減壓。

易漏

把貼三邊當成處理完成，後續不重評。 拔出異物或自行針刺胸部。

考規與差異 | 記這四點

本班

技術：平時 50 + OHCA 25 + 情境 25，合計□76；OHCA 與情境各□19。

BLS 扣分

核心任何錯誤 / 至少兩項不標準，綜合扣 10；一項不標準扣 6。實體品質用 QCPR / 教官判。

新指引

無反應或不能吞嚥不口服糖。胸傷敷料後惡化要鬆開 / 移除並重評。

EMT-1

不直接協助 NTG、吸入支氣管擴張劑或腎上腺素注射筆。詢問自備藥、回報進階救護。課堂差異向教官核對。